

Krankheit	Anamnese/Symptome	Status	Untersuchungen/ Abklärungen	Therapie	Kommentar
MUND					
Schmeckstörung	<u>Hypoguesie, Aguesie, Paraguesie, Phantoguesie</u> <u>Trigger:</u> Infekte, Hygiene, Alter, Psyche, Medis (Antimykotika), Mangelernährung, Neurologie, Chemo- und Radio-Tx etc.	Zunge + Mund inspizieren + palpieren , Sulcus amygdalogl., Motorik Zunge (Hypoglossus) Neurostatus: Trigemini testen (Sens., Sz., Kalt-Warm + Dermatome), Fazialis (Geschmack Ch. tympani + restl. Funktionen Fazialis), Glossopharyngeus (Geschmack)	Geschmack testen (Tast strips, + Geruch testen, Pat. verwechseln beides oft) Labor Ev. MRI/CT	Je nach Ursache: - Medi/Noxen-Stopp, Spontanerholung abwarten - Zink - meist keine Kausaltherapie	
Mukosa-Veränderungen (Mix)	Angina-Plaut-Vincenti: Spirochäten + Fusobakterien >Odynophagie >i.d.R. einseitig fibrinbedecktes Ulkus auf Tonsille >Gram-Präp >Mundflege + ev. Verätzung, AB (falls s. stark) Diphtherie: Corynebakt. Diphtheriae >Fieber, Schluck-Sz, LK >weissl. Beläge auf Tonsille/Uvula/Gaumensegel/Larynx, Azetongeruch >Abstrich + Kultur >Antiserum + Augmentin, Gurgeln Mononukleose/Pfeiff. Drüsenfieber: EBV > AZ red., Fieber, Kopf- + Glieder-Sz., Bauch-sz., kein Appetit, Schwellung Waldeyerring, LK, Systemerkrankung (Leber!) >Tonsillen hochrot + geschwollen, gelbl-grau-schleimige konflu. Beläge/Strassen>BE (atyp. LZ, mononukl. Zellen, Leberwerte, Serologie erst im Verlauf >IgM), US (Leber + Milz), EKG >symp. NSAID (kein Aspirin), Superinf. AB (KEIN Penicillin! >Exanthem), Bettruhe, kein Sport 6 Wo., Fluesssigkeit! Herpangina: Cocksackie-Viren >hoch Fieber, Hals/Kopf-Sz, Dysphagie >viele kl. sz.hafte Bläschen (roter Hof) am Gaumenbogen/Uvula/Tonsillen >symptomatisch (Gurgeln mit Aspegic, bei Kindern KI!!!) Stomatitis herpetica: HSV >Sz., Brennen, Fieber >Bläschen + Aphten an Lippen + Mukosa >Abstrich + Serologie >symptomatisch, AB bei Superinf., Acyclovir falls Komplik. (Encephal.) Angina granulotica necroticans: multiple Bakterien >sept. Bild, Ulkus + Nekrosen, Foetor, keine LK! >BE (Agranulozytose) >AB, B-Transfusion, Gurgeln Candida-Mykose/Soor-Stomatitis: fest-haftende bei Entf. blutende weisse Beläge, gerötete Mukosa >Abstrich>top. Antimykotika, Lutschtabletten, Fluconazol syst. (wenn larynx/Ö.) Herpes simplex labialis: HSV-I, Bläschen (auch enoral möglich) + ev. Krusten an Lippe >diverse Symptome, meist guter AZ >klin. Dx. >Desinfektion, Zovirax (Aciclovir)-Salbe od. syst. Perlèche/Faulecken: Eorsionen Lippenwinkel, ev. Krusten >Ursache: Speichelfluss, Prothesen, DM, Vit./Fe--Mangel, AB, Allergie, Lecken >Grunderkrankung, Hautschutz Herpes Zoster: VZV, gruppierte sz-hafte Bläschen, Ulzera+Krusten>Abstrich (PCR: Erregernachweis) >Aciclovir syst., NSAID, Carbamazepin (gg. Neuralgie), lokale AB, ev. top. St. Habituelle Apften: flach-ulzeröse Läsionen mit rotem Hof >Mundspülungen (Aspegic), Tinktur, Steroid-Gel, Thalidomid/Contergan falls s. schwer Blick-Dx: Lingua plicata (Melkersson-Rosenthal-Syndrom), schwarze Haarzunge (nach AB, Steroide etc.), L. geographica (normal, kann bei Psoriasis auftreten), Glossitis rhombica, Zungengrundstruma, Mundwinkelrhagaden (Vitaminmangel), Gingivitis/Peridontitis, Hypertrophe Hydrantoistomatitis, Fordyce-Anomalie, Ranula (Retentionszyste), Leukoplakie, Erythroplakie/M. Bowen, Orale Haar-Zell-L (Präkanzerose), Soor-Stomatitis, Herpes, Hunter Glossitis				
Fremdkörperaspiration	Was aspiriert? Prothese? Husten, Schleim, Zyanose, Stridor, Dyspnoe, Sz., Speichelfluss, FK-Gefühl, Dysphagie, Odynophagie	1. Inspektion (Zyanose, Speichelfluss, Mund/Rachen, ev. Laryngoskopie) 2. Auskultation	Rx-Thorax + Halsweichteile (Gastrographinbreischluck falls V.a. auf FK im Ö.) Pneumologen + Anästhesie (Intub. falls starre E.) informieren PVK legen, O2	1. Endoskopie* bzw. Bronchoskopie 2. Falls drohende Asphyxie: Heimlich-Manöver 3. Cortison, AB ev.	*zuerst flexibel >weicher FK wird in Magen gestossen, sonst mit dann mit starrer E. rausgefischt FK in Nase mit Häckchen entfernen (ev. LA/Sedation)

Ingestion (orale Einnahme tox. Stoffe)	Dysphagie, Odynophagie, Dyspnoe, Dyphonie	1. Inspektion (Zyanose, Mund-Rachen, ev. Laryngoskopie)	1. PVK legen 2. Endoskopie	1. Steroide (hochdosiert) 2. Flüssigkeit i.v. 3. AB (Breiband)	
Akute Atemnot	Atemnot, ev. Zyanose Fragen: FK, Beinschmerz, Panikattacke,	1. Pat. beruhigen, O2 2. Inspektion 3. Anästhesie rufen 4. Je nach Dringlichkeit untersuchen od. direkt Intubieren	> O2 geben, PVK 1. Adrenalin (inhalat., s.c.) 2. Antihistaminikum 3. Cortison 4. Atemweg sichern (Intub., Koniotomie od. Tracheotomie)	Ursache finden + behandeln: BE (D-Dimere u.a.) Rx-Thorax	I.d.R. macht man Tracheotomie (Konio s. selten)
Quincke-Ödem	akutes Oedem d. tieferen BG v. Lippe od. Augenlider od. Zunge od. Rachen, Atemnot, Zyanose	Atemweg sichern! PVK legen, Anästhesie rufen		Adrenalin, Cortison, Anthihist. , ev. Intubation , Noxen weg, bei C1-Estares-Mangel Gabe v. C1-Estares-Konz.	Ursachen: Histaminvermittelt (idop., ASS-Intol, ACE-H., allergisch/IgE, etc.) od. C1-Esterase-Mangel
Stottern	Wie war Entwicklung d. Kindes, Kindheit, psycho-soz. Umfeld (Erwartungen, Disziplin, wenig Geduld, Kritik), <u>Wiederholungen</u> , <u>Dehnungen</u> , <u>Blockierungen</u> , <u>Begleitphänomen</u> (z.B. auf Seite schauen od. Augen schliessen, lautere und höhere Stimme), in gew. Situationen symptomfrei (Speilen mit Puppen, Zählen, etc.), FA	Kind (Sprache, Spielverhalten, Gefühlsausdruck) + Eltern kennenlernen Übers Stottern sprechen HNO-Status Hörtest	Entwicklungsprofil, Sprachverständnis, Artikulation, Freispiel, Kommunikation mit Therapeut, Audit. + visuelle Wahrnehmung	Psychologie: Modifikation Stottern (Ängste, Vermeideverhalten + Anspannung abbauen) Spiel- + Sprechtherapie: Logopädie >Flüssiges Sprechen Wichtig: Eltern miteinbeziehen, ev. Psychotherapie	
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte	Trinken/Saugen erschwert, Übertritt v. Nahrung in Nase, offenes Näseln (Hyperrhinophonie), Palatolalie + -phonie, Ruckverlagerung Zunge, harte Stimmeinsätze, Verschlusslaute schwach (b, p, g, k), oft Tubenfunktionsstörung mit Hörverlust	Inspektion Mund- + Rachen Nase Gehör (Seromukotympanon, Cholesteatom) >Schalleitungsschwerhörigkeit)	Dx Nasalität: nasaler Airflow messen, Pusten/Blasen, Palpation, etc., nasale Endoskopie, Nasometrie Bildgebung (CT)	Saugen/Trinken: Trinkplatte, Flaschensauger, Löffelschoppen Gehör: Parazentese, Paukenröhrchendrainage Chirurgie: Verschluss Lippen, dann Weichgaumen, Später Hardgaumen Logopädie (Artikulation, Luftstrom) + ev. Psychologie	<u>Formen:</u> Lippenkerbe od. -spalte, Lippen-Kiefer-Spalte, Uvula bifida, submukose Spalte, hintere Gaumenspalte, Lippenkiefergaumenspalte LKG

Tumoren Mundhöhle (Zunge, Lippen, Gaumen, Mundboden, etc.)	RF: Rauchen, Alk, Präkanzerosen (L. planus, Erythro- + Leukoplakie, HPV, etc.), aktinische Keratose/UV, Luftverschmutzung, +FA	Untersuchung Mund (sehr gut auch Sulcus amygdalaglossus und Mundboden) + Rachen Lymphknoten	Panendoskopie mit Biopsien FNP (Zytologie), Biopsie US, CT (Knochen, Larynx), MRI (Weichteile), PET-CT (Staging v.a.)	<u>PE-Ca Mundboden: Teilresektion Mundboden</u> + bds. Neckdissection, <u>Mundbodenrekonstruktion</u> <u>PE-Ca Zungen-Ca: minimale Chirurg.</u> (falls keine Metast.) <u>PE-Ca-Zungengrund: RT-Chemo</u> <u>Leukoplakie, Erythroplakie, Condyloma: Exzision + Biopsie</u> <u>Candida: top. Antimykotika</u> <u>Lichen planus: top. Steroide</u> <u>Orale Haar-Zell-Leukoplakie: Vit.A-Säure, Podophyllin</u> <u>Mucormycosis: radikales Debridement, syst. Antimykotika</u>	90% PE-Ca! DD: Candida-Mykose, Leukoplakie , Fordyce-Anomalie, Lichen planus , orale Haarzell-Leukoplakie, Lingua geografica, Haarzunge, Erythroplakie , Hämangiom, Lymphangiom, Pyogenes granulom, HSV, M. Wegener, Mukormycosis, Condyloma acuminata
Kiefergelenkserkrankung	Kiefergelenksknacken, Sz., (beim Kaufen), Muskel-Sz., Trismus, Ohren-Sz., Schwellung, Zähneknirschen, Zahn-Sz., Systemerkrankungen (RA, >Morgensteifigkeit, Schwellung, Rheumaknoten, Deformation, etc.), Fieber (infekt. Arthritis), Dysphagie, Atemnot <u>Hinweise f. Tumor:</u> spontane Okklusionsstörung, Mittellinienabweichung v. UK bei Mundöffnung <u>RF:</u> Alter, Prothese, Mangelernährung, Infekte, Osteoporose, chron. Reize, Zahnverlust, Karies/Hygiene <u>RED FLAGS:</u> Trismus, Atemnot, F. canina Abszess, Dysphagie, CRP>100	Inspektion UK + OK (Symmetrie, Dysgnathie, Kammatrophy, Schwellung, Rötung), passive + aktive Beweglichkeit testen, Gelenk palpieren, Mundöffnung messen, Knacken hörbar? Trismus? Mund + Rachen inspizieren, Zähne (E., Abszess,), Alveolarkämme (Dicke/Atrophie), Lymphknoten	Labor (CRP, LK), US, CT (bei Logenabszess v.a.!), Zahn-Rx *falls kein Fieber, kein Trismus, akute Zahn-Sz., kein Eiterraustritt >keine AB sondern abwarten	<u>Bruxismus:</u> Stressabbau, Physio, Okklusionsschiene <u>Diskopathie:</u> Physio, Arthroskopie + Lavage, Hyaluronsäure Diskettomie/Arthroplastik <u>Arthrose:</u> NSAID, Steroide, Arthroplastik, Resektion Ankylosemasse (bei Ankylose) Synoviale Chondromatose: Arthrotomie, Entfernung Gelenkskörper, Resektion Synovia <u>Tumor:</u> je nach Typ Dentogene Infektion: AB*, Drainage (Abszess) >Abstrich, Spülung, Zahnbehandlung <u>Kieferkammatrophy:</u> Implantate, Hygiene, Knochenaufbau <u>Dysgnathie:</u> Chirurgie (bilat. sag. Schnitt od. Le-Fort-Osteotomie od. Mandibulo-maxill. Osteotomie), Genioplastik (Weichteile)	Bruxismus: Zähneknirschen Diskopathie: Luxation, Diskusverlagerung >Knacken,, Arthrose: Sz., z.T. Trismus, im Extremfall Ankylose mit Trismus Arthritis: i.R. RA od. Psoriasis z.B., infektiös, reaktiv od. postinfektiös Tumor: Synoviale Chondromatose, Osteochondrom, Sarkom Dentogene Infektion: submukoöser Abszess, Fossa canina-Abszess, Logenabszess Kieferkammatrophy: Reduktion Gesichtshöhe weil Atrophie/ Degeneration UK/OK Dysgnathie: Kieferfehlstellungen >Pro- + Retrognathie d. UK/OK, falls 6er-Zahn des OK nicht auf Höhe des 1. Molaren des UK zu liegen kommt bei Neutralbiss.
Periphere Fazialisparese	Trockenes Auge, Sz. Auge, Geschmacksverlust, keine Tränen mehr, Hypakusis, Probleme mit Mundschluss/Essen <u>RF:</u> Infekt (Ohr, obere Atemwege), Trauma, Schwellung Parotis (Tumor)	Inspektion (Bell-Phänomen/Parese, Ptose, Nasolabialfalte) Auge (Schirmertest, Spalt, Auflicht/Fluoreszin) Gehör (Hörtest, Stimmgabeln, Otoskopie, Stapediusreflex!) Mund (Mundschluss, Fazialistest, Geschmack testen) Neurostatus: Fazialistesten (periphere vs. zentrale Parese), Geschmack, Gehör	BE, Serologien (Borreliose, HSV, HIV, , ev. LP) Falls Persistenz >3Mte > MRI (Abklärung Parotis-Tumor)	Je nach Ursache! 1. Prednison Tbl. (10T.) 2. ev. Valtrex (Valaciclovir)* 3. Augentropfen/Salbe + Uhrglasverband falls Bell-Parese *falls Virus, auch wenn nicht erwiesen in Serologie!	<u>Ursachen:</u> entzündlich/infektiös, Traumatisch, Tumorbedingt <u>Periphere FP:</u> Stirnmuskulatur ausgefallen (meist idiopath., infektiös >Borreliose, HSV, HIV), traumatisch <u>Zentrale FP:</u> Stirnmuskulatur intakt, ZNS-Problem (Tumor, MS, CVI)